

SEPSE NEONATAL — ATB EMPÍRICO IMEDIATO

SEPSE PRECOCE vs TARDIA

Aspecto	Precoce (<72h)	Tardia (>72h)
Início	<72h de vida (geralmente <24h)	>72h de vida (até 28 dias ou mais)
Transmissão	Vertical (canal de parto/intraútero)	Horizontal (nosocomial, comunidade)
Agentes	Streptococcus do grupo B (GBS), E. coli, Listeria	Staphylococcus (coag-neg, aureus), Gram-neg, fungos
Fatores de risco	RPMO >18h, febre materna, GBS+, corioamnionite, prematuridade	Cateter central, VM prolongada, nutrição parenteral, internação
Foco	Pneumonia, bacteremia, meningite	Meningite, infecção de cateter, ITU, pele
ATB empírico	Ampicilina + gentamicina	Considerar vancomicina + cefepima/aminoglicosídeo

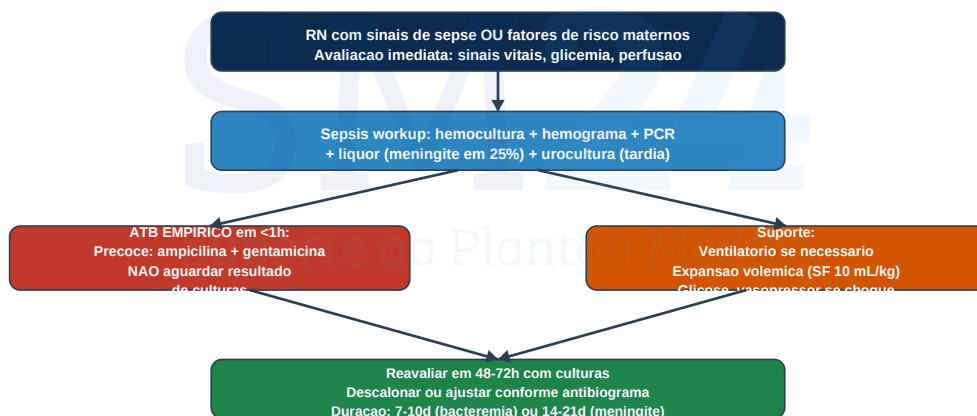
QUADRO CLÍNICO — SINAIS INESPECÍFICOS

NEONATO 'NÃO VAI BEM' = SEPSE ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO

- Instabilidade térmica: hipotermia (mais comum que febre no RN) ou febre
- Respiratório: taquipneia, gemência, retração, apneia, cianose
- Cardiovascular: taquicardia, bradicardia, má perfusão, hipotensão (sinal tardio)
- Neurológico: letargia, irritabilidade, hipotonia, convulsão, fontanela abaulada
- Gastrointestinal: recusa alimentar, vômitos, distensão abdominal, resíduo gástrico
- Outros: icterícia precoce, petéquias, hipoglicemia/hiperglicemia, acidose metabólica

ABORDAGEM DA SEPSE NEONATAL

SEPSE NEONATAL — CULTURAS + ATB EM 1H



ANTIBIOTICOTERAPIA — ESQUEMAS

Situação	ATB empírico	Observações
Sepse precoce	Ampicilina + gentamicina	Cobre GBS, E. coli, Listeria
Sepse tardia (comunidade)	Ampicilina + gentamicina ou cefotaxima	Considerar cobertura ampliada
Sepse tardia (nosocomial)	Vancomicina + cefepima ou aminoglicosídeo	Cobre S. aureus/coag-neg + Gram-neg resistente
Meningite confirmada	Ampicilina + cefotaxima (doses meníngeas)	Não usar ceftriaxona em RN (desloca bilirrubina)
Suspeita de fungo (UTIN, prematuro)	Adicionar anfotericina B ou fluconazol	Cândida em prematuros com cateter/NPT

GBS E PREVENÇÃO

Streptococcus do Grupo B (GBS)

- Principal agente de sepse precoce no RN a termo
- Rastreio materno: cultura vaginal/retal com 35-37 semanas
- Profilaxia intraparto: penicilina G IV se GBS+ ou fatores de risco
- Indicações de profilaxia: GBS+, bacteriúria por GBS, filho anterior com doença por GBS
- Fatores: RPMO >18h, febre intraparto >38°C, trabalho de parto prematuro
- Profilaxia adequada reduz sepse precoce por GBS em ~80%

Cuidado com Ceftriaxona

- Ceftriaxona é CONTRAINDICADA no RN icterico (<28 dias)
- Desloca a bilirrubina da albumina → risco de kernicterus
- Também: precipita com cálcio IV (risco de êmbolo)
- Usar cefotaxima como alternativa de cefalosporina de 3ª geração no RN
- Gentamicina: monitorar função renal e níveis séricos
- Punção lombar: indicada em RN com hemocultura positiva ou sinais neurológicos

EXAMES NA SUSPEITA DE SEPSE NEONATAL

SEPSIS WORKUP

- ☐ Hemocultura: padrão-ouro (antes do ATB, mas não atrasar o ATB se difícil)
- ☐ Hemograma completo: relação I/T (imaturos/totais) >0,2 sugere infecção; neutropenia é mau sinal
- ☐ PCR e procalcitonina: seriadas (1 valor isolado tem baixo VPP; PCR sobe em 6-12h)
- ☐ Punção lombar: meningite acompanha 25% das sepses; sempre se hemocultura+ ou sinais neurológicos
- ☐ Urocultura: na sepse tardia (por punção suprapúbica ou cateterismo)
- ☐ Glicemia, gasometria, eletrólitos: avaliar repercussão sistêmica

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

RN com 12 horas de vida, mãe com GBS positivo sem profilaxia adequada, apresenta hipotermia, gemência e recusa alimentar. Qual conduta?

- A) Observação e reavaliação em 24h
- B) Sepsis workup (culturas) + ATB empírico imediato com ampicilina + gentamicina
- C) Apenas hemograma e aguardar resultado antes de qualquer ATB
- D) Iniciar antibiótico oral
- E) Aquecer e alimentar, sem necessidade de investigação

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o principal agente etiológico da sepse neonatal precoce no RN a termo?

- A) Staphylococcus aureus
- B) Streptococcus do grupo B (GBS)
- C) Pseudomonas aeruginosa
- D) Candida albicans
- E) Staphylococcus coagulase-negativo

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Por que a ceftriaxona deve ser EVITADA no recém-nascido icteríco?

- A) Porque é nefrotóxica no RN
- B) Porque desloca a bilirrubina da albumina, aumentando o risco de kernicterus
- C) Porque não atravessa a barreira hematoencefálica
- D) Porque causa hipoglicemia
- E) Porque não cobre o GBS

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual é a profilaxia intraparto recomendada para gestante com cultura positiva para GBS?

- A) Azitromicina oral
- B) Penicilina G (ou ampicilina) intravenosa durante o trabalho de parto
- C) Ceftriaxona intramuscular dose única
- D) Metronidazol vaginal
- E) Nenhuma profilaxia é necessária

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Em RN com hemocultura positiva para sepse, qual exame complementar é mandatório por sua frequente associação?

- A) Ecocardiograma
- B) Punção lombar (meningite acompanha ~25% das sepses neonatais)
- C) Tomografia de crânio
- D) Ultrassom abdominal
- E) Eletroencefalograma

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

RN com sinais de sepse (hipotermia, gemência, recusa) + fator de risco (GBS+ sem profilaxia adequada): emergência. Sepsis workup (hemocultura, hemograma, PCR, considerar liquor) + ATB EMPÍRICO imediato (ampicilina + gentamicina) em <1h, sem aguardar culturas. Sinais no RN são inespecíficos e a deterioração é rápida.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Streptococcus do grupo B (GBS) é o principal agente da sepse neonatal precoce no RN a termo. Transmissão vertical pelo canal de parto. Outros: E. coli, Listeria monocytogenes. Profilaxia intraparto com penicilina reduz a incidência em ~80%.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Ceftriaxona desloca a bilirrubina dos sítios de ligação da albumina → aumenta a bilirrubina livre → risco de kernicterus (encefalopatia bilirrubínica) no RN icterico. Também precipita com cálcio IV. Usar cefotaxima como cefalosporina de 3a geração alternativa no neonato.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Profilaxia intraparto para GBS: penicilina G IV (ou ampicilina) durante o trabalho de parto, idealmente ≥4h antes do nascimento. Indicada em GBS+, bacteriúria por GBS, filho anterior com doença invasiva por GBS, ou fatores de risco (RPMO >18h, febre, prematuridade) sem cultura.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Punção lombar é mandatória em RN com hemocultura positiva, pois a meningite acompanha ~25% das sepses neonatais e exige ATB em doses meníngeas por tempo prolongado (14-21 dias). Também indicada quando há sinais neurológicos ou deterioração clínica.

SM24
Suporte ao Plantão Médico